Disciplina: PEDIATRIA II

Adenomegalias/ suspeita de câncer infantil

Prof. PATRICIA DAHAN

SUPREMA
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora

PLANO DE ENSINO

Curso: Medicina

Data: 2º Semestre de 2023 **Período:** 8º

Professor: PATRICIA DAHAN

Conteúdo Programático Abordado nesta aula:
Adenomegalias / suspeita de câncer infantil

SUPREMA



Objetivos da aula

- ✓ Conhecer abordagem diagnóstica de adenomegalias localizadas ou generalizadas , com ou sem sintomas/ sinais sistêmicos
- ✓ Conhecer os sinais de alerta para os tipos de câncer infantil

SUPREMA

Caso clínico – 1

Criança de 5 anos com febre há 3 dias, que não passa e caroço no pescoço.



SUPREMA

Caso clínico – 2

Trata-se de criança de 6 anos com **febre baixa há 10 dias**, sem foco definido, emagrecimento, palidez cutâneo –mucosa importante, hepatoesplenomegalia e hipertrofia linfonodal cervical, axilar e inguinal.

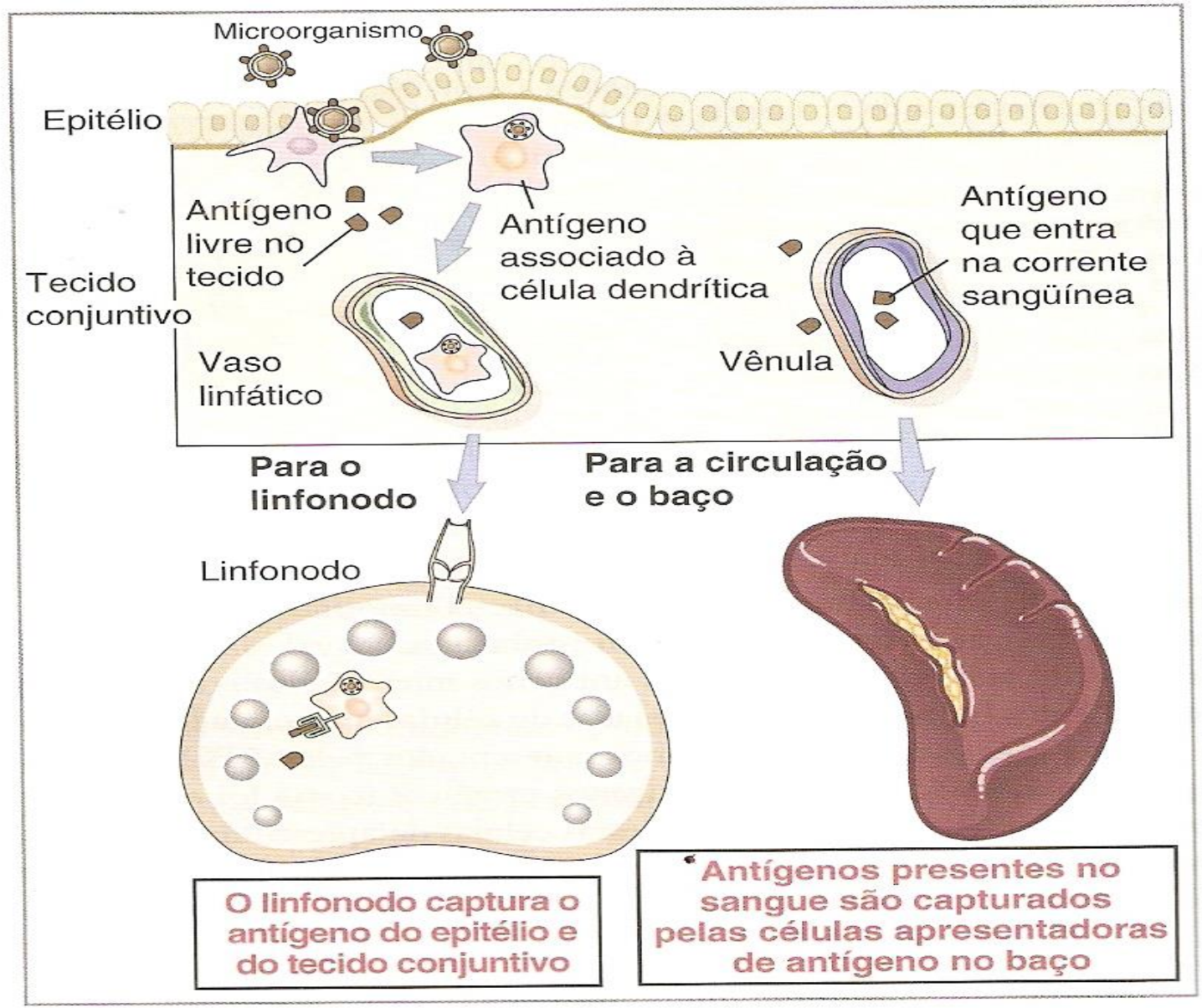
Faz diferença se compararmos os dois casos?

SUPREMA

Algumas considerações sobre sistema linfático

- Linfonodos: agregados nodulares de tecido linfóide ao longo dos canais linfáticos
- Vasos linfáticos: drenam líquidos (linfa) dos epitélios e tecido conjuntivo
- Nos linfonodos, as células apresentadoras de antígenos capturam os possíveis antígenos contidos na linfa. Além disso, as células dendríticas dos epitélios capturam os microorganismos e os transportam para os linfonodos

SUPREMA


Microorganismo
Epitélio
Antígeno livre no tecido
Antígeno associado à célula dendrítica
Antígeno que entra na corrente sangüínea
Tecido conjuntivo
Vaso linfático
Vênula
Para o linfonodo
Para a circulação e o baço
Linfonodo
O linfonodo captura o antígeno do epitélio e do tecido conjuntivo
Antígenos presentes no sangue são capturados pelas células apresentadoras de antígeno no baço

SUPREMA

O resultado desse processo de captura e transporte de antígenos se concentra nos linfonodos que drenam a região.

Implicação clínica



HIPERTROFIA DE LINFONODOS REGIONAIS

SUPREMA

Características gerais

- Associado ao crescimento normal do tecido linfóide ou a processo reativo de doenças benignas e autolimitadas.
- Crescimento acelerado até 2 anos de vida.

Exemplos:

- Baço palpável e hipertrofia de adenóides:
  - 14% dos RN e 7% das crianças menores que 10 anos
- Sombra tímica até 3 anos

SUPREMA

Timo



SUPREMA

LINFOADENOMEGALIA: AUMENTO NO TAMANHO DO(S) LINFONODO(S) PODENDO ESTAR ASSOCIADO A ALTERAÇÕES NO NÚMERO OU CONSISTÊNCIA

- **LINFOADENOMEGALIA LOCALIZADA: acometimento de linfonodos de regiões anatômicas contiguas (geralmente infecção ou neoplasias)**
- **LINFOADENOMEGALIA GENERALIZADA : acometimento de linfonodos de mais do que duas cadeias não contíguas (associada a várias doenças)**

- Linfadenopatia ou adenopatia: Aumento e/ou inflamação do linfonodo
- Hiperplasia reacional: maior causa de linfadenopatia na pediatria

SUPREMA

COMO AVALIAR ?

1) <u>Tempo de evolução</u>

Menos que 2 semanas ou sem aumento no último ano: provavelmente benigno

Ponto de coorte (biopsia) : geralmente 4 semanas

2) <u>Localização</u>

Anormais em regiões como epitrocleares, supraclaviculares, cervical inferior, pré auriculares, poplíteas etc

3) <u>Tamanho / consistência / aderência</u>

maior que 2-3 cm *suspeita

Aumento progressivo e/ou persistência

Consistência endurecida / fixos a planos profundos *

4) <u>Localizada ou generalizada</u>

SUPREMA

COMO AVALIAR ?

5) <u>Idade do paciente :</u>

probabilidade de etiologia maligna aumenta com idade do paciente

6) <u>Presença de sinais/sintomas sugestivos de doença sistêmica</u> :

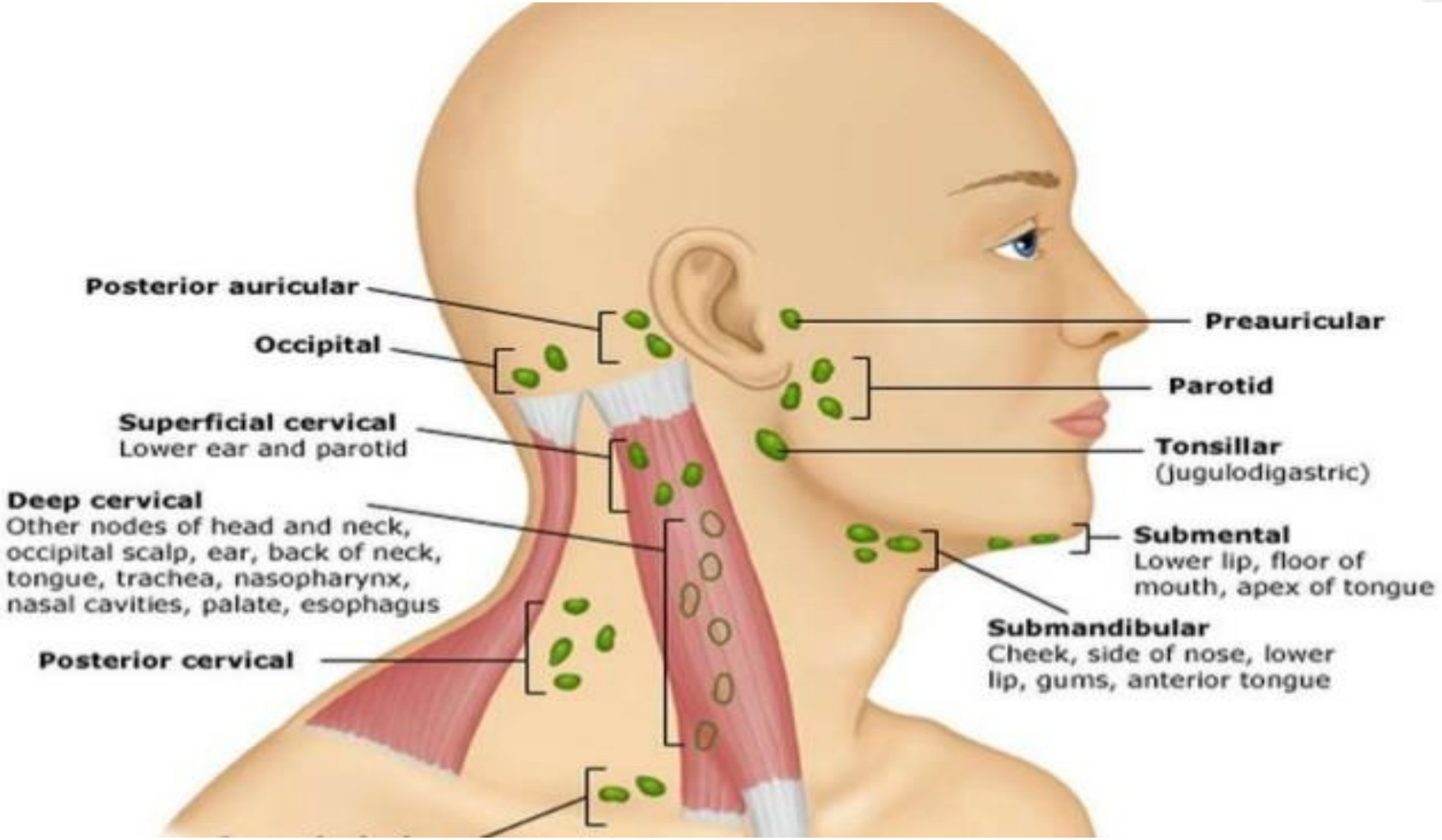
febre inexplicada, perda de peso, astenia , sangramentos , palidez, dor óssea ou articular ,sudorese noturna, dor abdominal inexplicada, petéquias ou equimoses, hepatoesplenomegalia

SUPREMA

Outros:

- **História vacinal (difteria, sarampo, rubéola)**
- **Viagens a áreas endêmicas**
- **Contatos com pessoas doentes (família ou comunidade – TB, infecções respiratórias, CMV, EBV, *Streptococcus* Beta hemolítico do grupo A)**
- **Uso de medicamentos (Fenitoína e Carbamazepina)**
- **Problemas dentais: anaeróbios**
- **Lesões na pele / trauma: *S aureus,* arranhadura do gato (*Rochalimaea henselae*)**

SUPREMA


Posterior auricular
Occipital
Superficial cervical
Lower ear and parotid
Deep cervical
Other nodes of head and neck, occipital scalp, ear, back of neck, tongue, trachea, nasopharynx, nasal cavities, palate, esophagus
Posterior cervical
Preauricular
Parotid
Tonsillar
(jugulodigastric)
Submental
Lower lip, floor of mouth, apex of tongue
Submandibular
Cheek, side of nose, lower lip, gums, anterior tongue

SUPREMA



SUPREMA

Massas cervicais:

Em crianças e adolescentes:

75% - causas infecciosas e/ ou inflamatórias

20% - alterações do desenvolvimento embrionário (cistos, linfangiomas e hemangiomas)

5% - neoplasias

Aguda < 6 semanas (sub aguda de 2 a 6 semanas)

Crônica > 6 semanas

SUPREMA

ETIOLOGIAS - INFECCIOSAS

Infeccção	Agente/Doença
Bacterias	**Staphylococcus aureus** **Streptococcus β-hemolítico do grupo-A** Anaeróbios Difteria Doença da arranhadura do gato **Micobactérias atípicas** **Tuberculose**
Vírus	**Infecções virais de vias aéreas superiores** **Epstein-Barr vírus**, Citomegalovirus Rubéola Varicella-zoster vírus Herpes simplex Coxsackievirus HIV
Protozoários	Doença de Chagas **Toxoplasmose**
Parasitas	Miíase Pediculose
Fungos	**Paracocidiodomicose** Histoplasmose

SUPREMA

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Apresentação	Comum	Incomum
Aguda Bilateral	**Rhinovirus e Adenovirus** **Enterovirus** **EBV & CMV** HSV M. pneumoniae Group A streptococcus	Roseola Parvovirus B19
Aguda unilateral	**Staphylococcus aureus** **Group A streptococcus** Anaerobic bacteria	Group B streptococcus Tularemia Alpha streptococcus Pasteurella multocida Yersinia pestis
Crônica Unilateral	**Nontuberculous Mycobacterium** **Cat scratch disease**	Toxoplasmosis Tuberculosis Actinomycosis
Crônica Bilateral	**Epstein-Barr virus** **Cytomegalovirus**	**HIV** **Toxoplasmosis** **Tuberculosis** Syphilis

SUPREMA

Quadro 1: Área de drenagem e principais causas de adenomegalia localizada

Cadeia ganglionar	Área de drenagem	Principais causas
Occipital	Porções posteriores do couro cabeludo e pescoço	Leões de couro cabeludo, rubéola, outras infecções virais
Pré-auricular e infra-orbitária	Pálpebras, saco conjuntival, pele da região temporal	Síndrome oculoglandular (tracoma, clamídia, adenovírus) Doença da arranhadura do gato Linfoma de Hodgkin Tuberculose, LUES, Chagas
Submandibular e submentoniano	Mucosa da boca, dentes, pele da face (região geniana), parte da drenagem das amígdalas	Amidalites, lesões de boca, LUES, caxumba, rinofaringites
Cervicais	Superiores: parte da língua, ouvido externo, parótida. Inferiores: cabeça, pescoço, laringe, traquéia, tireóide, braços, pulmões, mediastino, abdome	IVAS, mononucleose infecciosa, adenite piogênica, tuberculose, histoplasmose, toxoplasmose, leptospirose, doença da arranhadura do gato, neoplasias (linfomas, leucemia), histiocitose, pós-vacinal

(continua..

SUPREMA

(...continuação)

Cadeia ganglionar	Área de drenagem	Principais causas
Supraclavicular	Membros superiores, porção superior do tórax, abdome	À esquerda: lesões intra-abdominais (infecções, neoplasias) À direita: lesões torácicas
Axilares	Membros superiores, parede torácica, mamas, parede abdominal superior	Adenite piogênica, inflamação de pele, pós-BCG, neoplasias, Doença da Arranhadura do Gato
Epitrocleares	Mão e antebraço	Infecções de pele, LUES secundária, doença reumatológica com acometimento de mãos/punhos, Doença da Arranhadura do Gato
Inguinais	Membros inferiores, genitais, pele do abdome inferior, região glútea, canal anal	Infecções de membros inferiores, linfogranuloma venéreo, LUES primária, herpes genital, filariose
Poplíteos	Joelho, pele da perna e do pé	Infecção local importante

SUPREMA

Abordagem laboratorial

Essencialmente

diagnóstico clínico

(anamnese e exame físico)

- Alguns dos exames que podem ser necessários: Hemograma, PPD, sorologias (toxoplasmose, mononucleose, rubéola, Doença de Chagas, Sífilis, Blastomicose, Citomegalovírus, Hepatite), RX/TC tórax, Mielograma , provas de atividade reumática etc

SUPREMA

Outros exames:

- **Coleta de material por aspiração**
  - Cultura para aeróbios, anaeróbios, fungos, tuberculose
  - Bacterioscopia pelo Gram e BAAR
- **Biópsia para casos selecionados;**
  - Persistência maior que 4 semanas
  - supra-clavicular e cervical inferior;
  - Aumento dos gânglios no período de observação
  - Infartamento ganglionar profundo
  - Associada a sintomatologia de doença grave, alterações radiológicas ou no hemograma inexplicadas, sem melhora após tratamento
- **Desidrogenase lática e ac úrico (aumentados em neoplasias)**
- **Exames de imagem : radiografia de tórax, US abdominal, TC tórax e abdome**

SUPREMA

Adenopatias inflamatórias

- Dolorosas
- Flutuação
- Sinais na pele
- Fistulização

Neoplásicas

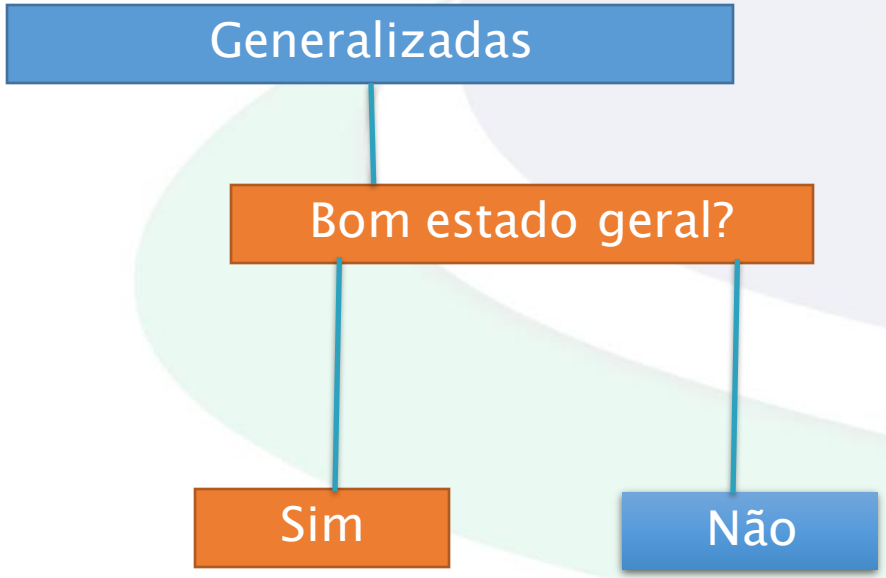
- **Duras**
- **Aderidas**
- **Não dolorosas**
- **Confluentes**
- **Supra-clavicular**

- **Adenomegalia ≥2,5 cm = neoplasia ou patologia inflamatória crônica**
- **Adenopatia crônica, persistente e progressiva**

SUPREMA

ABORDAGEM
ADENOMEGALIA





Abordagem diagnóstica:

Linfonodos localizados

- Estado geral satisfatório podendo ter febre
- Linfonodos inflamados (eritematosos e doloridos)
- Especialmente cervicais superiores (ângulo da mandíbula e submandibulares)
- Piodermite, conjuntivite, otite, amigdalite

→ Sugere adenite → HEMOGRAMA VHS /PCR

HEMOGRAMA – leucocitose com neutrofilia
PCR/ VHS ↑

→

1. Tratar com antibiótico (10 dias)
2. Reavaliar necessidade de drenagem
3. Se não houver melhora – BIÓPSIA

SUPREMA

Adenite piogênica







Adenite satélite



SUPREMA

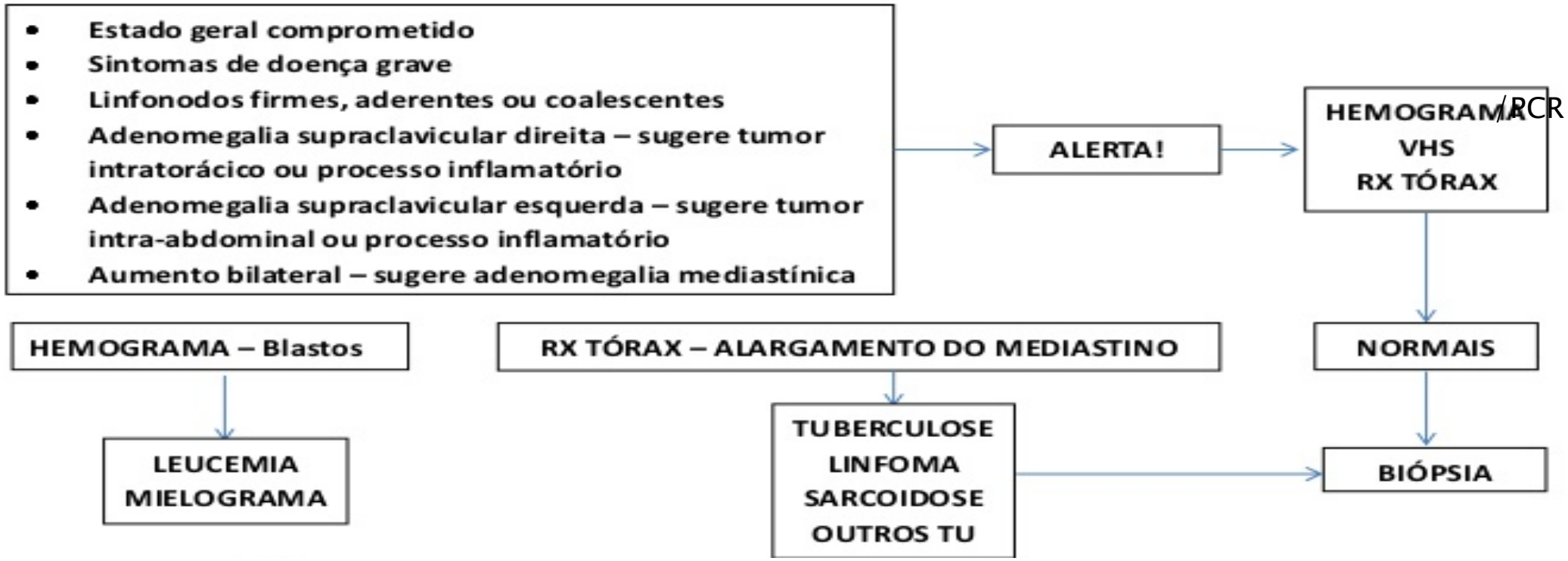
Tratamento inicial:

- Cefalexina – 25 a 50 mg/kg/dia 6/ 6 horas
- Cefuroxima 20-30 mg/kg/dia 12/12 horas
- Azitromicina (>6 meses) 10 mg/kg dose inicial / depois 5mg/kg/ dia do mais 4 dias
- Clindamicina 10-20 mg/kg/dia de 6 em 6 horas ou 8 em 8 horas (máx 1,8g)
  - MRSA ou anaeróbios
- Resposta nas primeiras 24 – 48 horas
- Se não responder – PAAF e/ou drenagem

SUPREMA

Abordagem diagnóstica:

Linfonodos localizados com sinais de gravidade e/ou doença sistêmica



SUPREMA



SUPREMA

- **Situação específica de linfonodos localizados em axila direita após BCG**

  - Estado geral bom
  - Com ou sem sinais flogísticos

  - Notificar + quimioprofilaxia com isoniazida

SUPREMA

Abordagem diagnóstica:

Linfonodos generalizados com bom estado geral

ADENOMEGALIA GENERALIZADA

- Estado geral bom
- Linfonodos de aspecto benigno, indolores, elásticos, não coalescentes, não aderidos, sem fístula, móveis
- Com ou sem febre e hepatoesplenomegalia

→

Solicitar

HEMOGRAMA

VHS /PCR

SOROLOGIA EPSTEIN-BARR

CMV

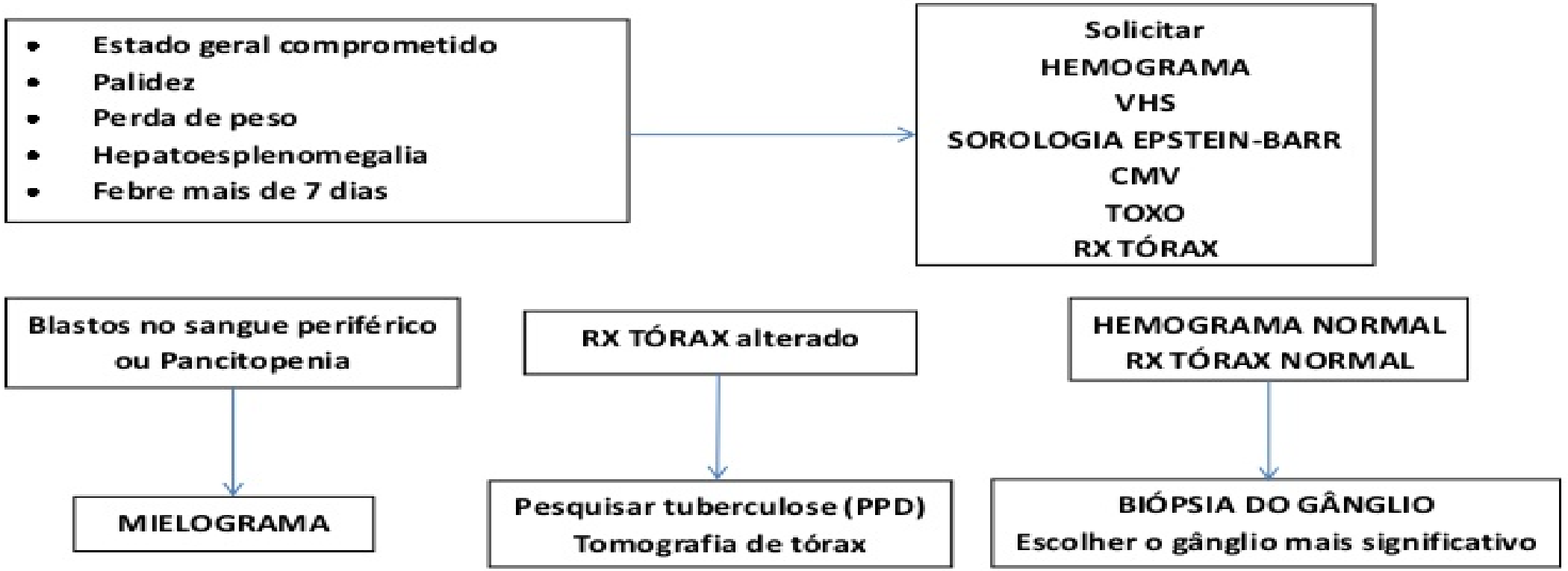
TOXO

RX TÓRAX

SUPREMA

Abordagem diagnóstica:

Linfonodos generalizados com comprometimento do estado geral



SUPREMA

Massas cervicais:

OUTROS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS





segunda, terceira e quarta fendas branquiais).

SUPREMA

Higroma cístico



FIGURA 1: Higroma cístico de face. Aumento de volume da hemiface direita



FIGURA 4: Evolução após seis meses. Involução significativa após infecção local



SUPREMA

Câncer infantil

- Não é prevenível
- 2-6% do total de casos de câncer / 6000 casos novos por ano (INCA)
- Menor período de latência.
- Crescem rapidamente e são mais invasivos
- Respondem melhor ao tratamento (70-80% cura) e tem melhor prognóstico do que em adultos desde que diagnosticados precocemente

- *RECENTEMENTE : menor evolução na sobrevida e menor redução na mortalidade = reflexo de diferenças na biologia tumoral,* ***no diagnóstico mais tardio*** *e na menor participação em protocolos de tratamento.*

SUPREMA

Câncer infantil

DIFICULDADES NO DIAGNÓSTICO :

- **RAROS**
- **GERALMENTE OS SINTOMAS SÃO VAGOS E COMUNS A OUTRAS DOENÇAS DA INFÂNCIA**

SUPREMA

Câncer infantil

- **LEUCEMIAS E OS TUMORES CEREBRAIS**, 10% cada.
- **TUMORES ÓSSEOS E SARCOMAS DE PARTES MOLES** 8% cada.
- **CARCINOMA DE TIREOIDE E OS TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS TESTICULARES**, 7% cada.
- Na adolescência manifestam-se **TUMORES DE ORIGEM EPITELIAL**,(praticamente ausentes na infância)

SUPREMA

Câncer infantil

SUBGRUPOS

- **TODAS AS IDADES** : linfoma não Hodgkin, leucemias e tumores de sistema nervoso central.
- **ADOLESCENTE** : linfoma de Hodgkin, osteossarcoma e tumor testicular.
  - Mais graves /mais agressivos
- **CÂNCER DA INFÂNCIA COM APRESENTAÇÃO TARDIA**: rabdomiossarcoma, neuroblastoma e tumores renais.
- **CÂNCER DO ADULTO COM APRESENTAÇÃO PRECOCE**: carcinoma de tireoide, carcinomas do trato digestório e melanoma.

SUPREMA

Dificuldades no diagnóstico

- Muitas vezes **SINAIS & SINTOMAS INESPECÍFICOS** que não permitem localização (febre, vômitos, dor óssea,palidez, emagrecimento etc.…)
- Em alguns casos, sintomas com acometimento mais localizado (cefaleia, alterações visuais, dor abdominal etc…)

SUPREMA

IMPORTANTE

- **Não alarmar** os pais antes da confirmação

- Mas alertar quanto a necessidade de investigação PRECOCE

O CÂNCER PEDIÁTRICO É UMA DOENÇA POTENCIALMENTE CURÁVEL SE DIAGNÓSTICADA PRECOCEMENTE

SUPREMA

Quadro 5 – Sinais e sintomas do câncer infantil e o seu diagnóstico diferencial

Sinais e Sintomas	Tipos de Câncer	Diagnóstico Diferencial
Febre	Leucemia, linfoma	Infecção
Vômito	Massa abdominal, tumor cerebral	Infecção, refluxo gastroesofagiano
Constipação	Massa abdominal	Má alimentação
Tosse	Massa mediastinal	Infecção no trato respiratório superior, doença respiratória reativa, pneumonia
Dor óssea ou muscular	Leucemia, tumor ósseo, neuroblastoma	Lesão musculoesquelética, infecção viral
Dor de cabeça	Tumor cerebral	Cefaleia de tensão, enxaqueca, infecção
Linfadenopatia (> 2 cm)	Leucemia, linfoma, doença metastática	Linfadenite, infecção sistêmica, doença do colágeno
Hematúria	Tumor de Wilms	Infecção do trato urinário, glomerulonefrite

SUPREMA

SUSPEIÇÃO MALIGNIDADE

Sinais de Alerta:

- Palidez ou anemia ou pancitopenia
- Febre persistente
- Emagrecimento
- Hepatoesplenomegalia
- Gânglios: Aderidos a planos profundos ou à pele, coalescentes, endurecidos, supraclaviculares
- Envolvimento mediastinal em RX/TC de Tórax

SUPREMA

LEUCEMIAS

Câncer mais comum na infância

- Leucemia linfoide aguda (LLA):80% dos casos
  - pico de incidência entre 2-4 anos de idade.
- Leucemia mieloide aguda (LMA):15-20% dos casos de leucemias
  - mais frequente em crianças com menos de 1 ano de idade e em adolescentes.

SUPREMA

LEUCEMIAS

- **PANCITOPENIA** (Anemia, leucopenia e trombocitopenia) são formas comuns de apresentação de **Leucemias agudas na infância**
- **Latência curta**
- Sintomas associados: palidez, fadiga, irritabilidade, febre inexplicada, linfadenopatia generalizada, **dor óssea persistente ou inexplicada**, equimoses, petéquias, hepatoesplenomegalia, hemorragias (epistaxe por ex)

A Leucemia pode principiar com alterações ósseas e articulares, as vezes com hemograma ainda normal. Imperativo o acompanhamento destas crianças.

SUPREMA

LINFOMAS

- Entre as 3 neoplasias mais comuns na faixa etária pediátrica.

- Aumento ganglionar (outros tumores podem causar acometimento ganglionar)

- LINFOMA HODGKIN E LINFOMA NÃO HODGKIN

SUPREMA

LINFOMAS

- **LINFOMA DE HODGKIN**: mais comum nos jovens adultos (dos 15 aos 40 anos) e pessoas acima dos 55 anos de idade. raro antes dos 5 anos de idade.

  SUSPEITA: crescimento de linfonodos por mais de 2 semanas, associado ou não a quadros inflamatórios ou infecciosos (linfonodos cervicais, supraclaviculares e mediastinais em até 70%dos casos). Sintomas sistêmicos, como febre, sudorese e perda de peso não são frequentes e significam maior agressividade da neoplasia.

- **LINFOMA NÃO HODGKIN**: ALTO grau de malignidade/ agressivos. A idade de maior frequência da doença varia com o tipo histológico.
  - Linfoma de Burkitt (mais frequentemente <10 anos): massa abdominal ou comprometimento mandibular
  - Linfoma linfoblástico (geralmente >10 anos) acometimento mediastinal em 50-70% dos casos, com derrame pleural, desconforto respiratório grave por compressão direta das vias aéreas

SUPREMA

TUMOR CEREBRAL

- tumores malignos sólidos mais comuns em crianças.
- cerca de 20% das neoplasias abaixo de 15 anos de idade.
- pico de incidência ocorre na primeira década de vida
- **PODE OCORRER ATRASO DIAGNÓSTICO NA CRIANÇA MENOR PELA INCAPACIDADE DE SE QUEIXAR**
- **Mas 95% das crianças com cefaleia e TU cerebral tem achados neurológicos**

SUPREMA

Suspeita de TUMOR CEREBRAL

Sintomas sugestivos de tumor cerebral

- Cefaléia matinal recorrente associada a vômitos
- Cefaléia que acorda a criança
- Cefaléia intensa e incapacitante
- Mudança na qualidade, frequência, e padrão da cefaléia

Alterações neurológicas **95% das crianças com cefaleia e TU cerebral tem achados neurológicos** - Convulsões de início recente (sem febre / sem doença de base)/ Distúrbios visuais (diplopia, estrabismo)/ Alterações marcha (equilibrio, coordenação) / Sinais motores (paraparesia)/ Queda do rendimento escolar ou perda dos marcos do desenvolvimento/ Alterações inexplicadas do comportamento ou humor/ Alteração de nível de consciência

SUPREMA

Suspeita de TUMOR ÓSSEO

40% das LLA apresentam sintomas musculoesqueléticos ao diagnóstico.
80% dos tumores ósseos apresentam dor intermitente ao diagnóstico.

Geralmente há história de trauma associado no início do quadro.

Mais intensa à noite e em repouso.

Os tumores ósseos mais frequentes :

- Osteossarcoma (10-19 anos / mais comum em fêmur distal, tíbia proximal ou úmero proximal / cura de 55-85%)
- Sarcoma de Ewing (10-15 anos/ cura 55-75%)

SUPREMA

MASSA ABDOMINAL

Período neonatal: malformações congênitas (GU e GI) BENIGNAS

Lactente até 5 anos: tumor maligno

- NEUROBLASTOMA (pico : 2 anos) massa palpável, dor óssea, irritabilidade, palidez , febre, perda ponderal

- TUMOR DE WILMS (ou nefroblastoma) .Geralmente apresenta-se como massa assintomática (60%), encontrada acidentalmente pelos pais. Hipertensão arterial (25%), hematúria (15%), dor abdominal (8%). Pico de incidência: 3 a 4 anos de idade.

SUPREMA

MASSA TESTICULAR

- 75% dos casos são malignos
- Geralmente indolor
- Diferencial com torção de testículo, hidrocele

LEUCOCORIA

- Reflexo pupilar branco anormal ou róseo ou amarelo esbranquiçado
- Ocorre em mais de 50% dos pacientes com **retinoblastoma**
- **Média diagnóstico : 2 anos (<4anos)**

SUPREMA



SUPREMA


1
Dolor persistente en huesos y abdomen
2
Fiebre sin causas, o por más de una semana
3
Moretones o sangrado de nariz o encías
4
Crecimiento tumoral o de ganglios
5
Picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel
SIGNOS DE ALERTA PARA EL CÁNCER INFANTIL
6
Cansancio fácil, palidez y anemia súbita
7
Pérdida de peso
8
Dolor de cabeza y vómitos por la mañana, por varios días
9
Abdomen que crece rápidamente
10
Infección que no mejora

A



SUPREMA



OS SINTOMAS DO CÂNCER INFANTIL PRECISAM MAIS DA SUA ATENÇÃO.

SUPREMA


DORES
NOS
OSSOS
www.acacci.org.br
OS SINTOMAS DO CÂNCER INFANTIL PRECISAM MAIS DA SUA ATENÇÃO.
Fique de olho no seu filho e nestes sintomas:
• Dores nos ossos, juntas, cestas e fraturas fáceis • Perda de peso, palidez e cansaço inexplicados, ou sangramentos sem machucado • Manchas roxas ao redor dos olhos ou pelo corpo • Alteração no andar ou perda de equilíbrio e da fala • Reflexo esbranquiçado nos olhos, estrabismo recente, perda da visão ou crescimento do olho • Caroço em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga • Dor de cabeça por mais de 2 semanas com ou sem vômitos ou aumento do tamanho da cabeça • Febre prolongada e inexplicada.
Se observar a persistência de qualquer um deles, de forma progressiva, procure um pediatra. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 80%.
Acesse acacci.org.br e entenda melhor todos os sintomas.
Seja voluntário
REDE GAZETA
ACACCI
21 2125-2999

SUPREMA


Reflexo nos olhos
www.acacci.org.br
OS SINTOMAS DO CÂNCER INFANTIL PRECISAM MAIS DA SUA ATENÇÃO.
Fique de olho no seu filho e nestes sintomas:
• Reflexo esbranquiçado nos olhos, estrabismo recente, perda da visão ou crescimento do olho • Perda de peso, palidez e cansaço inexplicados, ou sangramentos sem machucado • Dores nos ossos, juntas, costas e fraturas fáceis • Manchas roxas ao redor dos olhos ou pelo corpo • Alteração no andar ou perda de equilíbrio e da fala • Caroço em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga • Dor de cabeça por mais de 2 semanas com ou sem vômitos ou aumento do tamanho da cabeça • Febre prolongada e inexplicada.
Se observar a persistência de qualquer um deles, de forma progressiva, procure um pediatra. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 80%.
Acesse acacci.org.br e entenda melhor todos os sintomas.
Seja voluntário
REDE GAZETA
ACACCI
21 2125-2999

SUPREMA


palidez inexplicada
OS SINTOMAS DO CÂNCER INFANTIL PRECISAM MAIS DA SUA ATENÇÃO.
Fique de olho no seu filho e nestes sintomas:
• Perda de peso, palidez e cansaço inexplicados, ou sangramentos sem machucado • Reflexo esbranquiçado nos olhos, estrabismo recente, perda da visão ou crescimento do olho • Dores nos ossos, juntas, costas e fraturas fáceis • Manchas roxas ao redor dos olhos ou pelo corpo • Alteração no andar ou perda de equilíbrio e da fala • Caroço em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga • Dor de cabeça por mais de 2 semanas com ou sem vômitos ou aumento do tamanho da cabeça • Febre prolongada e inexplicada.
Se observar a persistência de qualquer um deles, de forma progressiva, procure um pediatra. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 80%.
Acesse acacci.org.br e entenda melhor todos os sintomas.
Seja voluntário
REDE GAZETA
ACACCI
21 2125-2999

SUPREMA


MANCHAS ROXAS
www.acacci.org.br
OS SINTOMAS DO CÂNCER INFANTIL PRECISAM MAIS DA SUA ATENÇÃO.
Fique de olho no seu filho e nestes sintomas:
• Manchas roxas ao redor dos olhos ou pelo corpo • Perda de peso, palidez e cansaço inexplicados, ou sangramentos sem machucado • Dores nos ossos, juntas, costas e fraturas fáceis • Alteração no andar ou perda de equilíbrio e da fala • Reflexo esbranquiçado nos olhos, estrabismo recente, perda da visão ou crescimento do olho • Caroço em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga • Dor de cabeça por mais de 2 semanas com ou sem vômitos ou aumento do tamanho da cabeça • Febre prolongada e inexplicada.
Se observar a persistência de qualquer um deles, de forma progressiva, procure um pediatra. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 80%.
Acesse acacci.org.br e entenda melhor todos os sintomas.
Seja voluntário
REDE GAZETA
ACACCI
21 2125-2999

SUPREMA


CAROÇO NO CORPO
www.acacci.org.br
OS SINTOMAS DO CÂNCER INFANTIL PRECISAM MAIS DA SUA ATENÇÃO.
Fique de olho no seu filho e nestes sintomas:
• Caroço em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga • Perda de peso, palidez e cansaço inexplicados, ou sangramentos sem machucado • Reflexo esbranquiçado nos olhos, estrabismo recente, perda da visão ou crescimento do olho • Dores nos ossos, juntas, costas e fraturas fáceis • Manchas roxas ao redor dos olhos ou pelo corpo • Alteração no andar ou perda de equilíbrio e da fala • Dor de cabeça por mais de 2 semanas com ou sem vômitos ou aumento do tamanho da cabeça • Febre prolongada e inexplicada.
Se observar a persistência de qualquer um deles, de forma progressiva, procure um pediatra. Com o diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 80%.
Acesse acacci.org.br e entenda melhor todos os sintomas.
Seja voluntário
Apoio:
REDE GAZET
portal
medianeira

SUPREMA

Referências

- MARCONDES, E. et al. **Pediatria básica**. São Paulo: Sarvier; 2003.
- LOPES, F.A; DIOCLÉCIO,C.J; BURNS,D.A.R. **Tratado de Pediatria- Sociedade Brasileira de Pediatria.** São Paulo : Manole 3ª Ed. 2017.

- http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/protocolo-de-diagnostico-precoce-do-cancer-pediatrico.pdf
- C-Doc-Cientifico-Oncologia-Epidemiol-30-mar-17.pdf (sbp.com.br)
- 23715c-NotaEspecial - Setembro Dourado 2022.indd (sbp.com.br)

SUPREMA